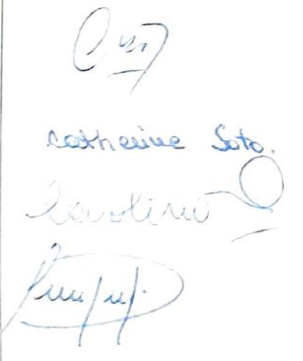


	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 1 de 8

Protocolo de Instalación de Vía Venosa Periférica.

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.

Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por: EU Joselyn Castro C. EU M° Carolina Cornejo Z. EU Sandy Guajardo P. EU Catherine Soto F.	Revisado por: EU. María José Solís L.	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargo: Enfermeras CESFAM Peralillo.	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad.	Cargo: Director CESFAM Peralillo.
Fecha: 22 de Febrero 2024	Fecha: 27 de Febrero 2024	Fecha: 12 de Marzo 2024
Firma: 	Firma: 	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 2 de 8

I. INTRODUCCION.

Se entiende por acceso venoso periférico, el abordaje de una vena superficial de localización extra aponeurótica, generalmente en las extremidades superiores, siendo más excepcional las extremidades inferiores en los adultos. La instalación de un catéter venoso periférico o vía venosa periférica (VVP), es un procedimiento invasivo muy frecuente en la actualidad, utilizado para entregar al paciente una atención de enfermería eficiente y oportuna. Se trata de la introducción de una cánula de teflón a través de una vena periférica del paciente, empujado por un mandril metálico, que se retira una vez la cánula se encuentra dentro de la vena. Esta técnica requiere de condiciones de asepsia a fin de prevenir infecciones asociados a procedimientos invasivos y manejo de la práctica clínica, para brindar condiciones seguras en la entrega de atención directa al paciente.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General

Establecer la estandarización del procedimiento de instalación y manejo del acceso vascular periférico, considerando la prevención de IAAS y eventos adversos asociados.

b. Objetivos específicos

- Unificar criterios en el equipo de salud para la instalación y manejo de los pacientes con vías venosas periféricas.
- Realizar una valoración adecuada del paciente, dirigida a pesquisar complicaciones reales o potenciales en el manejo de vías venosas periféricas.
- Minimizar las complicaciones relacionadas con la presencia de dispositivos periféricos, mediante un correcto manejo.

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 3 de 8

III. ALCANCE

Aplica a todos los funcionarios y unidades en que se realice instalación de vía venosa periférica.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- Médico: Indicación de instalación, mantención y retiro de vía venosa periférica.
- Enfermera: Instalación, mantención, retiro y supervisión del procedimiento.
- Técnicos en Enfermería: Instalación, mantención y retiro de VVP según indicación.

V. DEFINICIONES

Flebocllisis: Es la introducción de una solución en forma continua directamente al torrente sanguíneo a través de una cánula intravenosa.

Vía venosa periférica (VVP): Abordaje de una vena superficial de localización periférica, generalmente en las extremidades superiores, siendo de forma excepcional en adultos y niños en extremidades inferiores, y en neonatos en la cabeza. Se utiliza el acceso venoso periférico para prueba diagnóstica, administración de medicamentos, fluidos o alimentación vía intravenosa.

Obstrucción: Oclusión total o parcial del teflón por un coágulo de sangre o flexión de teflón.

Flebitis: Enrojecimiento, inflamación o dolor referido en el sitio de punción o trayecto de la vena canalizada.

Extravasación: Salida de líquido intravenoso, soluciones o medicamento, hacia el espacio extravascular, motivado por factores propios del vaso o

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 4 de 8

accidentes derivados del desplazamiento de la cánula o catéter fuera de la venopunción.

Infección del sitio de inserción: Eritema, induración, mayor sensibilidad y/o exudado en un área de 2 centímetros en torno al punto de exteriorización. Puede asociarse o no con otros síntomas y signos de infección, tales como fiebre o pus en el sitio de la salida, con o sin infección del torrente sanguíneo concomitante.

VI. DESARROLLO DEL PROCESO

INSTALACIÓN VÍA VENOSA PERIFÉRICA

Equipo e insumos:

- Catéteres intravenosos de diferentes calibres.
- Llaves de tres pasos o tapa heparinizada.
- Cubierta estéril (transparente adhesivo).
- Tela adhesiva.
- Tórulas de algodón secas.
- Antiséptico Alcohol al 70%.
- Jeringa con suero fisiológico (para cebar y comprobar permeabilidad).
- Ligadura.
- Guantes de procedimiento.
- Alargador estéril de conexión al suero (opcional).
- Contenedor para material cortopunzante.

Procedimiento:

1. Realice lavado clínico de manos.
2. Identifique al paciente.
3. Acomode e informe al paciente procedimiento a realizar.

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 5 de 8

4. En caso de pacientes pediátricos explicar el procedimiento a acompañantes y la necesidad de inmovilización si es necesario.
5. En caso de pacientes pediátricos y neonatales solicite ayuda para inmovilización.
6. Inspeccione sitio a puncionar.
7. Elija el sitio de punción.
8. Elija el calibre del catéter (que cumpla la función para lo que está destinado).
9. Limpie sitio de punción con agua y jabón en caso de suciedad visible y luego lávese las manos.
10. Colóquese guantes de procedimiento.
11. Ligue a lo menos 4 traveses de dedos sobre el sitio a puncionar.
12. Palpe la vena a puncionar siguiendo el trayecto de ésta.
13. Limpie la zona con solución antiséptica (Alcohol 70%) y espere evaporación (30 segundos).
14. Puncione la piel con el catéter periférico, sin contaminar, con el bisel hacia arriba, en un ángulo entre 10 y 20° lateral o sobre la vena, lentamente hasta que refluya sangre.
15. Soltar la fijación cuando observe el retorno venoso, retire mandril y deposítelo en contenedor de material corto punzante. Avance el catéter hasta canalizar la vena.
16. Conecte la llave de tres pasos, y/o alargadores que se usarán para administrar soluciones o medicamentos.
17. Asegure circuito cerrado en todo el sistema y verifique vigencia.
18. Proteja zona de inserción del catéter con apósito estéril, luego complete la fijación con tela adhesiva, registre fecha, calibre del catéter, nombre de la persona responsable del procedimiento sobre fijación.
19. Conecte guía para fleboclisis si corresponde.

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 6 de 8

20. Retire el material utilizado de la unidad.

21. Deseche guantes.

22. Lave sus manos una vez finalizado el procedimiento.

23. Registre el procedimiento en DAU (Dato de Atención de Urgencias) de ficha electrónica FONENDO en caso de servicio de urgencia rural o ficha clínica en caso de CESFAM y Postas dependientes.

CAMBIO O RETIRADA DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO:

- Reemplazar el catéter venoso periférico cada 72 horas en usuarios con tratamientos por más de tres días. (En CESFAM se realiza atención ambulatoria y atención domiciliaria)
- Cambiar el catéter siempre que exista flebitis, extravasación, obstrucción y/o sospecha de infección en el sitio de inserción, en este caso se debe reemplazar el sitio de punción de inmediato.
- Se debe cambiar el sitio de punción cada vez que se cambie el catéter.

RECOMENDACIONES:

1. Establecer la necesidad de insertar un catéter.
2. Elegir el menor calibre posible tras valorar el acceso a la vena, la enfermedad y las características del fármaco.
3. Limitar el uso de llave tres pasos y de catéteres de varios lúmenes ya que representan mayor número de puerta de entrada para los microorganismos.
4. Buscar accesos preferentemente en las extremidades superiores y evitar zonas de flexión.
5. No emplear la extremidad afectada en caso de extirpación ganglionar, fistula arterio-venosa y quemaduras, ACV secuelado, piel no indemne.

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 7 de 8

VII. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Peralillo.
- Servicio de Urgencia Rural (SUR)
- Postas Rurales: Población, Los Cardos, Calleuque y EMR Rinconada de Molineros.
- Unidad de Calidad y seguridad de Usuario, CESFAM Peralillo.
- Box de enfermería.
- Alumnos de pregrado y Docente guía.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Cifuentes, (2015).L GCL-1.24-VVP. 1° ed., pp. 6, 7, 8. <http://www.hospitaliquique.cl/images/PCI/GCL-1.24-VVP.pdf> [recuperado 10 de octubre de 2017]
- Torres, V. Rubio, M. García, G & González, R. (2012) SGC-PR-PMCVP/GCL 1.2.4. 1° ed. <http://hospitalrancagua.cl/wp-content/uploads/2014/10/GCL-1.2.4-Instalaci%C3%B3n-y-manejo-via-venosa-periferica-HRR-V1-2012.pdf> [recuperado 26 de diciembre 2017].
- Serie de orientaciones técnicas de enfermería, subdirección gestión del cuidado servicio de salud Viña del Mar-Quillota (2017)

IX. AUTORES

EU Joselyn Castro Cornejo

EU M° Carolina Cornejo Zamorano

EU Sandy Guajardo Padilla

EU M° José Solís Letelier

EU Catherine Soto Farías.

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 8 de 8

X. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	TIPO	APROBACIÓN